1. CONCEITO: Pneumonia em paciente em uso de VM por um período maior que dois dias consecutivos de calendário (sendo que o D1 é o dia de início do uso de VM) e que, na data da infecção, o paciente estava em uso de VM ou o VM havia sido removido no dia anterior

1.1 Responsáveis pela execução

Profissionais de saúde assistencialistas.

1.2 Finalidade

- Reduzir o risco de pneumonia associada a assistência à saúde em paciente internados nesta instituição.

1.3 Indicações

Pacientes internados nesta unidade de saúde.

2. MATERIAIS

- Bundlle de PAV
- Preparação alcóolica e sabonete líquido
- Material para aspiração
- Material para higiene oral
- Cuf

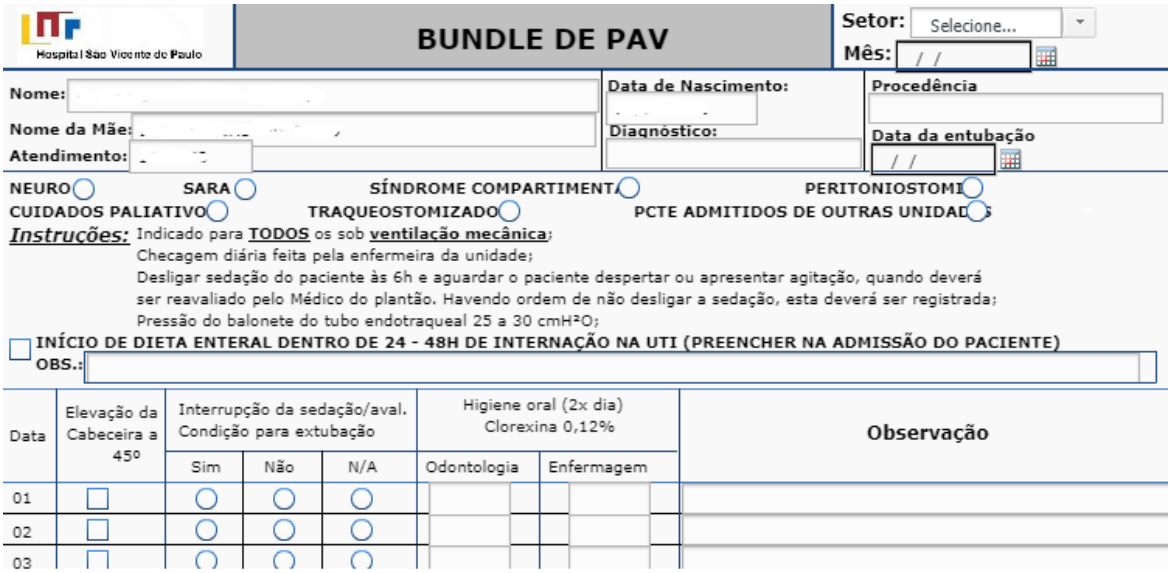
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS - MEDIDAS GERAIS
Higiene das mãos
Higienizar as mãos nos cinco momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizando a técnica correta com preparação alcoólica 70% ou com água e sabonete líquido, conforme a presença de sujidade visível;
Estimular essa prática entre pacientes, acompanhantes, visitantes e profissionais de apoio que atendem a unidade.
Ventilação mecânica não invasiva (VNI) ou cânula nasal de alto fluxo (CNAF)
Sempre que possível dar preferência para uso de VNI ou CNAF.
Condicionamento físico
Estimular a mobilização precoce do paciente no leito, quando indicado.
Engajamento de pacientes e familiares
Orientar paciente, acompanhantes e visitantes sobre a importância da higiene das mãos;
Indicar os locais que podem utilizar para realizar a higiene das mãos, com água e sabonete líquido e com preparação alcoólica;
orientar visitantes e acompanhantes a não compartilharem objetos com outros pacientes, acompanhantes e visitantes e a não tocarem nas superfícies de outros pacientes;
Orientar sobre a importância da realização de higiene oral, da manutenção da cabeceira elevada e sobre outras medidas de prevenção, para que possam comunicar aos profissionais de saúde sempre que observar alguma inconformidade;
Atualizar periodicamente o paciente e acompanhante sobre as decisões relacionadas ao processo de cuidado e necessidade de novas medidas de prevenção de infecção.
Orientar pacientes e acompanhantes sobre os principais fatores de risco de infecção e as medidas gerais e específicas de prevenção para que possam compreender e participar do processo de cuidado e prevenção;
Incluir o paciente e familiares no estabelecimento dos objetivos diários dos cuidados;

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS – MEDIDAS ESPECÍFICAS
Manutenção do decúbito elevado (30 45°)
Manter decúbito da cama na posição 30 a 45°;
Não elevar o decúbito em contraindicações clínicas;
Monitorar o decúbito na folha de controle da enfermagem – realizar medição ou conferência do ângulo da cabeceira da cama a cada turno;
Discutir sobre a adesão à medida durante as visitas multidisciplinares.
Teste de despertar diário (Avaliação da redução do nível de sedação e possibilidade de extubação)
Utilizar a menor dose possível de sedação;
Diariamente avaliar a possibilidade de diminuição do nível de sedação, com registro em prontuário;
Avaliar retirada do suporte respiratório invasivo, quando necessário, realizar teste de respiração espontânea;
Avaliar a prontidão do paciente para a desintubação;
Discutir o nível de sedação do paciente e possibilidade de extubação durante visita multiprofissional.
Aspiração da secreção subglótica
Realizar avaliação clínica periódica do paciente quanto ao volume e presença de secreções orais e faríngeas;
Executar aspiração orofaríngea com técnica asséptica sempre que houver acúmulo visível de secreção, desconforto respiratório, ou ruídos adventícios sugestivos de secreção alta;
Utilizar sistema de aspiração fechado, minimizando a manipulação excessiva e o risco de contaminação cruzada;
Utilizar tubos orotraqueais com porta de aspiração subglótica preferencialmente desde o início da ventilação mecânica, em pacientes de risco;
Realizar a aspiração de forma intermitente ou contínua, garantindo a manutenção da permeabilidade da via de drenagem.
Higiene oral
Realizar a higiene oral por pelo menos três vezes ao dia;
Realizar higiene oral com escova de dente para pacientes com dentição e gaze com espátula para partes moles.
Avaliar a necessidade do uso de antisséptico oral de acordo com o quadro do paciente (presença de infecção bucal evidenciada pelo cirurgião-dentista;
Hidratar a pele e lábios, incluindo a comissura labial, mucosas, gengivas e dorso lingual;
Realizar o procedimento com cabeceira elevada e com material padronizado pela instituição.
Cuidados com o circuito do ventilador
Trocar o circuito respiratório apenas em caso de sujidade visível, mau funcionamento técnico ou contaminação documentada, conforme diretrizes institucionais e recomendações da CCIRAS;

Avaliar frequentemente o posicionamento do circuito respiratório e o acúmulo de condensado, evitando que o líquido retorne para o paciente;
Proceder à remoção do condensado com técnica segura e uso de EPIs adequados;
Nunca drenar o condensado em direção ao paciente;
Durante o preparo do leito: − conectar o circuito respiratório ao ventilador e realizar o teste do equipamento para assegurar o correto funcionamento; − após o teste, embalar o circuito no próprio saco plástico de origem, mantendo identificação clara com etiqueta "limpo e testado", data e assinatura do responsável; − Obs.: essa prática deve estar padronizada por POP da instituição e não deve ser utilizada como substituição à higienização ou à troca necessária por contaminação;
Verificar, antes da utilização do ventilador, a integridade e a validade dos filtros inspiratórios e expiratórios, encaminhando os mesmos para limpeza e desinfecção entre os pacientes;
Realizar a troca dos filtros conforme as recomendações do fabricante do equipamento ou em menor intervalo, caso observada obstrução, sujidade, presença de condensado ou falha técnica;
Garantir que a troca dos filtros seja documentada e rastreável, com identificação do responsável; seja realizada entre pacientes, como medida preventiva de infecção cruzada; e utilize somente insumos aprovados e compatíveis com o modelo do ventilador.
Indicação e cuidados com os umidificadores
Substituir o sistema de umidificação quando em mau funcionamento ou visivelmente contaminado;
Dar preferência ao umidificador passivo (filtro Heat and Moisture Exchanger - HME);
Trocar a partir de 48 horas de uso, podendo ser utilizado no máximo até 7 dias , ou antes, caso apresente alguma alteração de integridade ou, prioritariamente, conforme a recomendação do fabricante;
Avaliar diariamente o filtro quanto à saturação e funcionamento.
Indicação e cuidados com o sistema de aspiração
Trocar o sistema fechado de aspiração a cada 72 horas ou, prioritariamente, conforme a recomendação do fabricante, ou quando houver sujidade ou mau funcionamento;
Utilizar sondas de aspiração e luvas estéreis e trocá-las a cada uso em caso de utilização de sistema de aspiração aberto;
Higienizar as mãos antes de calçar e após retirar as luvas
Extubação
Evitar extubação não programada (acidental) e reintubação;
Monitorar e ajustar sempre que necessário a fixação do tubo;
Monitorizar a frequência de extubações acidentais e notificar.
Cuidados com o cuff
Manter a pressão entre 18 e 22 mmHg ou entre 25 e 30 cm H2O (quando utilizado medidor de cuff), faixa segura para prevenir microaspiração sem causar lesão traqueal;

Evitar pressão abaixo de 25 cmH_2O (risco de aspiração) e acima de 30 cmH_2O (risco de lesão isquêmica da mucosa traqueal);
Documentar os valores aferidos e reajustar quando necessário, utilizando técnica asséptica.
Cuidados com inaladores e nebulizadores
Dar preferência à utilização de medicamentos em aerossol em apresentação de dose única, evitando frascos multidoses ou manipulação desnecessária;
Utilizar água estéril e medicamentos estéreis em todas as preparações para inalação e nebulização;
Descartar frascos de água estéril abertos imediatamente após o uso;
Para dispositivos reutilizáveis (nebulizadores simples, reservatórios): − garantir uso exclusivo por paciente; − armazenar em embalagem plástica limpa e identificada à beira-leito; − trocar os equipamentos a cada 24 horas ou antes, se houver recomendação do fabricante, sujidade ou falha de funcionamento;
Nos casos de nebulização contínua seguir as recomendações específicas do fabricante e instituir protocolo institucional;
Sempre que possível, preferir o uso de inaladores dosimetrados (MDI) com espaçadores, por serem mais seguros e com menor risco de contaminação, desde que disponíveis e apropriados ao paciente.
Sonda/cateter enteral na posição pós pilórica
Sonda/cateter enteral na posição pós pilórica
Iniciar a nutrição enteral precoce (início menor que 48 horas);
Priorizar a via enteral em relação à nutrição parenteral, reservando esta última apenas para casos em que a via enteral esteja contraindicada ou se mostre insuficiente;
Considerar o uso de sonda pós-pilórica em pacientes com alto risco de aspiração, como os que apresentam gastroparesia, refluxo, regurgitação, volume residual gástrico elevado ou histórico de PAV;
Garantir que a posição da sonda seja verificada após inserção, por meio de técnica apropriada (como raio-X) e documentada em prontuário.
Traqueostomia precoce
Considerar traqueostomia precoce, dentro de 7 dias da intubação;
Discutir os potenciais benefícios caso a caso, levando em consideração os valores e preferências do paciente/familiares sobre quando realizar o procedimento.
Processamento e descarte de produtos de assistência respiratória
Nunca utilizar produtos de assistência respiratória sem estar devidamente limpo e desinfectado ou esterilizado;
Esterilizar produtos de assistência respiratória classificados como críticos após adequada limpeza;
Realizar limpeza e, no mínimo, desinfecção de nível intermediário em produtos de assistência respiratória classificados como semicríticos (sempre que possível, adotar a desinfecção de alto nível ou a termodesinfecção);
Limpar e desinfetar respirômetros, sensores de oxigênio, manuvacuômetro, ventilômetros e outros dispositivos a cada paciente
Inspirômetros podem ser utilizados pelo mesmo paciente enquanto este possuir indicação de uso; após isso, os mesmos devem ser descartados.

6. ILUSTRAÇÕES/ ANEXOS



Hospital São Vicente de Paulo

BUNDLE DE PAV

Setor: Selecione...

Mês: / /

Nome:

Nome da Mãe:

Atendimento:

Data de Nascimento:

Diagnóstico:

Procedência

Data da entubação / /

NEURO ◯ SARA ◯ SÍNDROME COMPARTIMENTA ◯ PERITONIOSTOMI ◯

CUIDADOS PALIATIVO ◯ TRAQUEOSTOMIZADO ◯ PCTE ADMITIDOS DE OUTRAS UNIDAD ◯

Instruções: Indicado para **TODOS** os sob **ventilação mecânica**;
Checagem diária feita pela enfermeira da unidade;
Desligar sedação do paciente às 6h e aguardar o paciente despertar ou apresentar agitação, quando deverá ser reavaliado pelo Médico do plantão. Havendo ordem de não desligar a sedação, esta deverá ser registrada;
Pressão do balonete do tubo endotraqueal 25 a 30 cmH^2O;

☐ **INÍCIO DE DIETA ENTERAL DENTRO DE 24 - 48H DE INTERNAÇÃO NA UTI (PREENCHER NA ADMISSÃO DO PACIENTE)**

OBS.:

Data	Elevação da Cabeceira a 45º	Interrupção da sedação/aval. Condição para extubação			Higiene oral (2x dia) Clorexina 0,12%		Observação
		Sim	Não	N/A	Odontologia	Enfermagem	
01	☐	◯	◯	◯			
02	☐	◯	◯	◯			
03	☐	◯	◯	◯			

7. REFERÊNCIAS

-https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/2020/nota-tecnica-no-01-2024-vigilancia-das-iras

-https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-4-medidas-de-prevencao-de-infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf

-https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201706/28144222-1335379976-indicadores-nacionais-de-infeccoes-relacionadas-a-assistencia-a-saude.pdf

Protocolo de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Brasília (DF): Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; 2025. p. 31

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	**DATA**	**DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO**
01	15/05/2025	Elaboração
01	15/05/2025	Aprovação e publicação
02	30/05/2026	Atualização

Versão 1 – Elaboração Júlia R. Chaves P.Leite Ana Carolina Gomes de Farias	Data: 31/05/2025
Versão 2 – Atualização Júlia R. Chaves P.Leite Ana Carolina Gomes de Farias	Data: 31/05/2026
Validação/Revisão Nayanne I. F. Mota Guerra Giuliana Marçal Matheus Soares	
Aprovação Matheus Soares Sônia da Silva Delgado	